

Fecha Última Actualización: 16-10-2022 19:18:13

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Ana Maria Collao Faundez
Edad : 75a 9m 28d
Dirección : Gran Avda N° 2554

Rut : 5.085.834-0
Fecha Nacto: 18/12/1946
Comuna : San Miguel

N° Archivo : 1625073
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8619 9356

N° Epicrisis
322512

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 22/08/2022 09:09

Días Estadía: 55

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 16/10/2022 18:54

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

obstrucción intestinal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICINA INTERNA

FECHA DE INGRESO HSR: 22/08/22
FECHA DE INGRESO UPC: 22/08/22
FECHA DE INGRESO UTIM: 11/10/22
Contacto: 986199356

ANTECEDENTES:

- Mórbidos: HTA, DM2 NIR, Hipoacusia
- Quirúrgicos: No refiere
- Fármacos: Fluoxetina
- Alergias: No refiere
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones: No recientes

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos presenta cuadro de 1 mes de evolución de disnea progresiva hasta hacerse de reposo, asociado a compromiso de conciencia cualitativo agregándose vómitos abundantes 24 horas previo a ingreso, por lo que es traída por familiares.

Ingresa al SU en malas condiciones generales, hipotensa, comprometida de conciencia.

Se realiza TAC AP que evidencia estenosis colónica en ángulo esplénico con acentuada dilatación de asas hacia proximal y neumatosis intestinal de colon ascendentes, signos sugerentes de isquemia. Además presenta dilatación esofágica hacia proximal y leve ascitis pelviana.

Se interpreta cuadro como obstrucción intestinal y se inicia manejo de soporte (DVA + IOT).

Se efectúa laparotomía exploradora el 22/08 donde se describe necrosis de colon derecho y transversal transmural, sin perforación. Se efectúa colectomía derecha y de transversal con ileostomía terminal. Muestra enviada a cultivo.

Durante pabellón se describe uso de NAD 0.1 + AD 0.04 + Tf 4 UGR + tf 4 Uplasma.

Se hospitaliza en UCI para continuar estudio y manejo,

Fecha Epicrisis : 16/10/2022 19:18

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:04

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 16-10-2022 19:18:13

Página 2 de 3

22/08 TAC AP: Examen limitado por artefacto de movimiento. Área de estenosis en ángulo esplénico del colon con acentuada dilatación patológica de asas hacia proximal, con neumatosis intestinal en el colon ascendente, signos sugerentes de isquemia. Considerar como primera posibilidad una neoplasia colónica. Indispensable correlacionar con estudio endoscópico dirigido. Leve ascitis en excavación pelviana. Dilatación patológica hacia proximal del esófago torácico. Secreciones en bronquios segmentarios y subsegmentarios en ambas bases pulmonares con atelectasias bibasales. Escaso derrame pleural izquierdo. Acentuada ateromatosis cálcica aortobilíaca

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Obstrucción Intestinal

- 22/08 Laparotomía exploradora ¿ Colectomía derecha/transverso + ileostomía terminal

- Obs Tu de colon

AKI KDIGO I

Compromiso de conciencia en estudio

Antecedentes

EVOLUCIÓN EN UPC

HDN: Cursó con FMO en contexto de shock mixto con isquemia intestinal. Altos requerimientos de DVA (NAD 0.1 + AD 0.03) que se titulan a la baja en base a volemicización hasta suspender. Dobutamina suspendida precozmente.

Resp: Extubación diferida inicialmente por signos de congestión pulmonar en contexto de falla renal. Finalmente se extuba el 09/09 consolidando weaning a VMNI.

Infeccioso: Inicialmente recibe ceftriaxona + metronidazol de forma empírica. En estudio de líquido peritoneal se logra aislar E coli MS por lo que completa ATB. Durante estadía en UPC cursa con alza de PI por lo que se pancultiva y se kaisla en CAET K oxytoca y E coli MS, recibiendo tratamiento con AMS con buena respuesta.

Nefro: En contexto de FMO al ingreso se objetiva AKI que responde adecuadamente a volemicización inicialmente, pero que posteriormente progresa hasta requerir TRR.

Hemato: Múltiples requerimientos transfusionales de GR y PLQ.

QX: Paciente que ingresa con obstrucción intestinal y necrosis colónica que requirió laparotomía de urgencia y resección, además de ileostomía terminal, con alta sospecha de Ca de colon (tumor a biopsia). Dada la presencia de melena por ileostomía se efectúa EDA (negativa) y ileoscopía (08/09) que evidencia restos hemáticos sin sangrado activo, probablemente por isquemia de mucosa. Posteriormente sin nuevos sangrados. De alta del punto de vista quirúrgico.

Neuro: Paciente con historia dudosa de disartria y compromiso de conciencia, sin posibilidad de evaluación en contexto de intubación. Sin neuroimágenes inicialmente. Evoluciona con importante polineuropatía de paciente crítico.

El 13/09 se traslada a intermedio quirúrgico para continuar manejo y estudio

EVOLUCIÓN INTERMEDIO QX

HDN: Por anemia y trombocitopenia se transfunden en total 2 UGR y 4 UPLQ. Recibe terapia depleitiva en contexto de anasarca con buena respuesta.

Resp: Con mala evolución, presenta aumento de requerimientos de oxígeno. TAC de tórax 13/09 con abundantes secreciones bronquiales y atelectasias completas de ambos LI, además de DP bilateral. Conexión a VMNI de manera continua, con mal acople. Se realiza IOT nuevamente el 18/09.

Infeccioso: En contexto de elevación de PI el 14/09 se inicia meropenem + vancomicina, agregándose anidulafungina para cubrir foco abdominal.

Neuro: Se realiza TAC de cerebro que descarta lesiones agudas, interpretándose compromiso de conciencia como multifactorial tóxico-metabólico.

Nefro: Dada falla renal con oliguria y aumento de VEC hasta anasarca paciente vuelve a requerir diálisis hasta el 17/09.

Nutrición: Recibiendo nutrición parenteral.

El 18/09 se traslada nuevamente a UPC dado deterioro ventilatorio con requerimiento de IOT.

EVOLUCIÓN 2DA PASADA UCI

HDN: Ingresa con bajos requerimientos de NAD que se titulan a la baja hasta suspender. Posteriormente con buena perfusión. Luego de TRR con mejor manejo de VEC.

Resp: Ingresa con requerimientos de VMI en contexto de compromiso multifactorial evidenciado en TAC (congestión, atelectasia, neumonía). Evoluciona favorablemente logrando extubación el 04/10. Durante el fin de semana con deterioro que requirió conexión a VMNI de manera acotada. Actualmente sin requerimientos de oxígeno, ventilando de manera espontánea.

Fecha Epicrisis : 16/10/2022 19:18

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 16-10-2022 19:18:13

Página 3 de 3

Regular mecánica que se interpreta como condicionada por congestión, a la espera de UFA en HD.

Infecioso: Al ingreso a UPC recibe de forma empírica meropenem + vancomicina + anidulafungina, suspendiendo esta última de forma precoz. Completa 10 días de ATB empíricos (hasta 26/09), con buena respuesta. Posteriormente presenta nueva alza de PI por lo que inicia imipenem de forma empírica. Se logra aislar E faecium Van B y S haemolyticus MR en HCs 29/09, además de PSAE MR en CAET 29/09, rotando antibióticos a colistin + linezolid (FI 04/10), con plan de completar 7 y 14 días, respectivamente, según indicación de infectología (hoy último día de colistin). PI en franco descenso

Neuro: Evoluciona con lenta mejoría luego de suspensión de sedo analgesia. Nuevo TAC de cerebro con importante atrofia, sin lesiones agudas. En estudio ampliado se objetiva nuevo elemento etiológico: hipotorioidismo sin tratamiento. Al momento de traslado se encuentra vigil espontánea pero reticente a obedecer órdenes.

Endocrino: En contexto de edema importante, hipotermia y compromiso de conciencia se realiza estudio con TSH que resulta en 80, con T4L 0.42. Se suplementa levotiroxina en altas dosis. En seguimiento por especialidad.

Nefro: Abundante congestión por sobrecarga de volumen requiriendo diálisis continua con UFA por 24 h = -11.000. Desde entonces con HD habitual bien tolerada. Pendiente definir en conjunto con especialidad cronicación.

Nutrición: Progresa con alimentación vía enteral con buena tolerancia, actualmente fresubin HP a 75 cc/h. Sin evaluación formal para determinar pronóstico en lo nutricional.

Dada estabilidad se decide traslado a UTIM para continuar estudio y manejo.

Sin retorno a UPC, techo UTIM sin IOT, sin RCP

En UTIM evoluciona con profundización del compromiso de conciencia, obs en relación a interurrencias médicas, y con deterioro del punto de vista infeccioso sin microbiología nueva aislada.

Dado no retorno a UCI y estado basal se define manejo hasta UTIM.

El día 16/10 evoluciona con falla respiratoria y hemodinámica, con tendencia a la hipotensión, desat. hasta 80% y respiración con patrón de gasping. Dado pronóstico y condiciones y en contexto de manejo hasta UTIM, se decide no realizar medidas invasivas, suspender medidas fútiles e iniciar BIC de morfina. A las 18:54 hrs se constata fallecimiento.

Diagnóstico de Egreso

obstrucción intestinal -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Sebastián Oksenberg Sharim
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/10/2022 19:18

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:04

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar